

Farmacos para los que no se ha observado interacción o una interacción probablemente sin importancia clínica

Paracetamol
El paracetamol no tuvo efecto sobre ninguno de los parámetros farmacocinéticos del paracetamol cuando se administró simultáneamente a tres pacientes epilépticos.

Anticoagulantes orales
En pacientes psicóticos (>11) no se observó interacción cuando se administró valproato con clozapina.

La coadministración de valproato (50 mg dos veces al día) y carbamazepina (100 mg tres veces al día) a voluntarios masculinos normales (>16) no tuvo efecto sobre la cinética en estado estacionario del fármaco.
La administración concomitante de valproato (500 mg dos veces al día) y buspirona (1 mg dos veces al día) en voluntarios varones normales con diagnóstico de una distracción del 17% en el adentramiento plasmático de buspirona.

Olanzapina
No es necesario ajustar la dosis de olanzapina cuando se administra de forma concomitante con valproato. La coadministración de valproato (500 mg dos veces al día) y olanzapina (5 mg) a adultos sanos (>16) provocó una reducción del 50% en el AUC de la olanzapina.

Anticóncupos orales
La administración de una dosis única de etinilrelatón (50 mcg)/levonorgestrel (250 mcg) a 4 mujeres en tratamiento con valproato (200 mg dos veces al día) durante 2 meses no reveló ninguna interacción farmacocinética.

La administración concomitante de valproato y topiramato se ha asociado con hiperglucemia y/o sin encefalopatía. La administración concomitante de topiramato con valproato no debe recomendarse a menos que se pueda controlar cuidadosamente los dos fármacos con los PUE. Puede ser prudente examinar los niveles de aminoácidos en sangre en pacientes en los que se ha informado de inicio de hipoglucemia.

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Embarazo

Riesgo moderado de exposición durante el embarazo

Existe un grado de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en mujeres expuestas a medicamentos antiepilépticos (FAE), incluido el diagnóstico de sodo, durante el embarazo.

Resumen de datos

Para su uso en la profilaxis de las migrañas, el valproato está contraindicado en mujeres embarazadas y en mujeres en edad fértil que no usan métodos anticonceptivos efectivos.

Para su uso en la epilepsia y el trastorno bipolar el valproato no debe usarse para tratar a mujeres que están embarazadas o que planean quedar embarazadas, a menos que otros medicamentos no hayan logrado controlar adecuadamente los síntomas o sean inaceptables de otro modo. Las mujeres con epilepsia que quedan embarazadas no deben discontinuar el valproato abruptamente, ya que esto puede precipitar el estado epiléptico con hipotensión materna y feto y riesgo de peligro para la madre.

El uso de valproato materno durante el embarazo puede aumentar el riesgo de malformaciones congénitas, particularmente defectos del tubo neural, incluida la espina bífida, pero también malformaciones que afectan a otros sistemas del cuerpo (por ej., defectos cardíacos, incluidos herniados urales, malformaciones cardiovasculares, hipodisplasias, malformaciones de los extremidades). Este riesgo depende de la dosis, en embargo, se no puede establecer una dosis umbral por debajo de la cual no existe ningún riesgo. La exposición intrauterina al valproato también puede provocar problemas de audición o pérdida de la audición. La politerapia con valproato con otros FAE puede aumentar aún más una mala redacción de malformaciones congénitas en comparación con la monoterapia con FAE. El riesgo de anomalías estructurales importantes es mayor durante el primer trimestre; sin embargo, pueden ocurrir otros efectos graves en el desarrollo con el uso de valproato durante el embarazo. La evidencia epidemiológica sugiere que los niños expuestos al valproato durante el embarazo tienen un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo en comparación con los niños expuestos a otro FAE en el útero o a ningún FAE en el útero.

Se ha informado epidemiológicamente que la exposición a Prodoxal de valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de trastornos del espectro autista.

En estudios con animales, la administración de valproato durante el embarazo resultó en malformaciones estructurales fetales similares a las observadas en humanos y defectos neuroconductuales en la descendencia en dosis clínicamente relevantes.

Ha habido informes de hipoglucemia en recién nacidos y casos mortales de insuficiencia hepática en lactantes después del uso materno de valproato durante el embarazo.

Las mujeres embarazadas que toman valproato pueden desarrollar malformaciones o anomalías de la coagulación, como trombocitopenia, hipofibrinogenemia y/o disminución de otros factores de la coagulación, lo que puede provocar complicaciones hemorrágicas en la madre y el feto.

Las pruebas de diagnóstico prenatal disponibles para detectar defectos del tubo neural y otros defectos deben ofrecerse a las mujeres embarazadas que toman valproato.

La evidencia sugiere que la suplementación con ácido fólico antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo disminuye el riesgo de defectos congénitos del tubo neural en la población general. No se sabe si el suplemento de ácido fólico reduce el riesgo de defectos congénitos de la descendencia de mujeres embarazadas que toman valproato. La suplementación con ácido fólico en el día del parto antes de la concepción puede reducir el embarazo, se debe recomendar de forma rutinaria a las pacientes que usan valproato. Las mujeres embarazadas que toman valproato durante el embarazo deben recibir asesoramiento sobre los riesgos de la exposición al valproato durante el embarazo y el riesgo de defectos congénitos importantes, así como el riesgo de defectos congénitos importantes, así como el riesgo de defectos congénitos importantes en el útero.

El uso de ácido fólico de 4 mg durante el embarazo puede reducir el riesgo de defectos congénitos importantes en el útero.

Riesgo moderado de exposición durante el embarazo a la enfermedad

Resumen de datos
Para prevenir complicaciones graves, las mujeres con epilepsia no deben suspender el valproato de forma abrupta, ya que esto puede precipitar un estado epiléptico con hipotensión materna y feto y riesgo de peligro para la madre.

Incluso las convulsiones menores pueden representar algún riesgo para el feto en desarrollo. Si un embarazo se puede considerar la suspensión de fármacos antes y durante el embarazo en pacientes individuales si la gravedad y la frecuencia del trastorno convulsivo representan una amenaza grave para la paciente.

Condiciones clínicas

Las mujeres embarazadas que toman valproato pueden desarrollar anomalías de la coagulación, como trombocitopenia, hipofibrinogenemia y/o disminución de otros factores de la coagulación, lo que puede provocar complicaciones hemorrágicas en la madre y el feto.

Se ha informado epidemiológicamente que la exposición a Prodoxal de valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de trastornos del espectro autista.

Se ha informado epidemiológicamente que la exposición a Prodoxal de valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de trastornos del espectro autista.

Datos

Obtención del tubo neural y otros anomalías estructurales

Existe una gran cantidad de evidencia que demuestra que la exposición al valproato en el útero aumenta el riesgo de defectos del tubo neural y otros defectos estructurales. Según los datos publicados por el Registro Nacional de Prevención de Defectos Congénitos de la CDC, el riesgo de espina bífida en la población general es de aproximadamente 0,6 a 0,7% (8 a 7 en 10 000 nacimientos) en comparación con el riesgo después de la exposición al valproato en el útero, que se estima en aproximadamente 1 a 2% (13 a 20 en 1000 nacimientos).

El Registro de Embarazo NAKED ha informado una tasa de malformación importante del 4 al 11 % en las tipo de mujeres expuestas a un promedio de 100 mg/día de monoterapia con valproato durante el embarazo. Estos datos muestran un riesgo hasta cinco veces mayor de defectos congénitos importantes que en la población general. La exposición al valproato en el útero a altas dosis (mayor de 100 mg/día) también se ha asociado con un mayor riesgo de defectos congénitos importantes. Las principales malformaciones congénitas incluyen casos de defectos del tubo neural, malformaciones cardiovasculares, defectos craneales (por ej., herniados urales, craneosinostosis), hipodisplasias, malformaciones de los extremidades (por ej., defectos de la extremidad superior o inferior).

Efectos sobre el coeficiente intelectual y la afectación del desarrollo neurológico
Los estudios epidemiológicos sugieren que los niños expuestos al valproato en el útero tienen puntajes de coeficiente intelectual (CI) más bajos que los niños expuestos a otro FAE en el útero o a ningún FAE en el útero. El más grande de estos estudios es un estudio de cohorte prospectivo realizado en los Estados Unidos y el Reino Unido que encontró que los niños con exposición prenatal al valproato (>40 mg/día) tienen puntajes de CI más bajos a los 6 años (IQ de 77 [CI de 65 a 90]) que los niños con exposición prenatal a los otros tratamientos de monoterapia con fármacos antiepilépticos evaluados: lamotrigina (100 mg/día; CI de 96%, 102-110), topiramato (150 mg/día; CI de 96%, 102-110) y fenitoína (100 mg/día; CI de 96%, 102-110). No se sabe cuánto tiempo los efectos cognitivos en los niños expuestos al valproato durante el embarazo. Debido a que las mujeres de este estudio estuvieron expuestas a los FAE durante el embarazo, no se pudo evaluar el CI del riesgo de disminución del coeficiente intelectual estático relacionado con un período de tiempo particular durante el embarazo.

Aunque los estudios disponibles tienen limitaciones metodológicas, el peso de la evidencia respalda una asociación causal entre la exposición al valproato en el útero y los efectos adversos posteriores en el desarrollo neurológico, incluidos aumentos en los trastornos del espectro autista y el trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). La evidencia observacional ha sugerido que la exposición a productos de valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de trastornos del espectro autista. En este estudio, los niños nacidos de madres que habían usado productos con valproato durante el embarazo tenían un riesgo 2,9 veces mayor (intervalo de confianza [IC] de 96%, 17-49) de desarrollar trastornos del espectro autista en comparación con los niños nacidos de madres que no habían estado expuestas a productos con valproato durante el embarazo.

Los riesgos adicionales de trastornos del espectro autista fueron del 4,4 % (IC del 96%, 2,6%-7,5%) en niños expuestos al valproato y del 1,5% (IC del 96%, 1,5%-1,8%) en niños no expuestos a productos con valproato.

Los estudios epidemiológicos sugieren que los niños que fueron expuestos al valproato en el útero tienen un mayor riesgo de TDAH (por ejemplo, 1,48 veces con 1,08-2,00) en comparación con los niños no expuestos. Debido a que estos estudios fueron de naturaleza observacional, las conclusiones con respecto a una asociación causal entre la exposición al valproato en el útero y un mayor riesgo de trastornos del espectro autista y TDAH no pueden considerarse definitivas.

Con

Hay informes de casos publicados de insuficiencia hepática fatal en hijas de mujeres que usaron valproato durante el embarazo.

Anticoncepción

En estudios de toxicidad en el desarrollo realizados en ratones, ratas, conejos y monos, se produjeron tasas aumentadas de anomalías estructurales fetales, retrasos del crecimiento intrauterino y muerte embrionaria después de la administración de valproato a animales preñados durante la organogénesis en dosis clínicamente relevantes (calculadas sobre una base corporal superficial [mg/kg] base). Valproato indujo malformaciones múltiples similares a las de los ratones de valproato sérico materno. Un estudio publicado en ratas de hasta seis años de edad no informó efectos adversos en el desarrollo o cognitivos después de la exposición al valproato a través de períodos críticos de organogénesis, y la respuesta histológica se comparó con los niveles maternos del fármaco. También se informaron anomalías conductuales (incluidas hiperactividad, hiperlocomoción y/o comportamiento hiperactivo) y cambios histopatológicos menores en células de ratón y tasa epéptica prenatal en dosis clínicamente relevantes de valproato.

Resumen de datos

El valproato se secreta en la leche humana. Los datos en la literatura publicada describen la presencia de valproato en la leche humana (rango: 0,1 mg/L a 3,3 mg/L), correspondiente a 1 % al 10 % de los niveles séricos maternos. Las concentraciones de valproato reducidas de las lactantes amamantadas de 2 días después del nacimiento a 12 meses después del parto oscilaron entre 0,7 mg/L y 4 mg/L, que corresponden al 1 % al 6 % de los niveles de valproato sérico materno. Un estudio publicado en ratas de hasta seis años de edad no informó efectos adversos en el desarrollo o cognitivos después de la exposición al valproato a través de la leche materna.

No hay datos para evaluar los efectos de valproato de sodo en la producción o excreción de leche.

Beneficios potenciales

Los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna deben considerarse junto con la necesidad clínica de valproato de sodo para el control de la epilepsia y el trastorno bipolar en el bebé amamantado y el bebé amamantado por valproato de sodo para la elección materna adecuada. Controle la lactante amamantada para detectar signos de daño hepático, como ictericia y hematomas o sangrado inusuales. Ha habido informes de malformaciones y anomalías de la coagulación en las hijas de mujeres que usaron valproato durante el embarazo.

Datos

Resumen

En un estudio prospectivo, se obtuvieron muestras de leche materna y sangre materna de 11 pacientes con epilepsia que lactaban valproato en dosis que oscilaron entre 300 mg/día y 2400 mg/día en los días 3 a 6 postparto. En 4 pacientes que lactaban valproato solo, la leche materna contenía una concentración promedio de valproato de 1,8 mg/L (rango: 1 mg/L a 2,2 mg/L), que correspondía al 4,8% de la concentración plasmática materna (rango: 2,7 a 4,7 %). En todos los pacientes (7 de los cuales estaban tomando otro FAE concomitantemente), se obtuvieron resultados similares para la concentración en leche materna (1,8 mg/L; rango: 0,4 mg/L a 3,3 mg/L) y la proporción de plásmas maternos (4,5 %, rango: 1,3 a 9,6 %).

Un estudio publicado de 6 meses de madre e hijas lactantes mostró los niveles de valproato sérico durante el tratamiento materno para el trastorno bipolar (750 mg/día) o epilepsia (1500 mg/día). Ninguna de las madres recibió valproato durante el embarazo y la lactante tenía un 13 % de la exposición materna de valproato sérico. Los niveles séricos de valproato en las niñas oscilaron entre 0,7 mg/L y 1,5 mg/L. Con niveles de valproato en suero materno cerca o dentro del rango terapéutico, la exposición infantil al fármaco del 0,9% al 2,6% de los niveles maternos. Del mismo modo, en 9 informes de lactancia materna de 720 mg/día de madre e hijas lactantes, la lactancia de lactantes de 3 meses a 1 año, la exposición infantil fue del 1,5% y el 0,9% de la leche materna, respectivamente.

Un estudio observacional multicéntrico prospectivo evaluó los efectos del desarrollo neurológico a largo plazo del uso de FAE en niñas, se incluyeron mujeres embarazadas que recibieron monoterapia para la epilepsia con evaluaciones de sus hijos a las edades de 5 y 6 años. Las madres tomaron la terapia con FAE durante el período de lactancia. Los CI ajustados medidos a los 3 años para niños amamantados y/o amamantados fueron 106 (n=11) y 94 (n=42), respectivamente (p=0,04). Para otros dominios cognitivos evaluados a los 6 años, no se observaron efectos adversos de la exposición a un FAE (incluido el valproato) a través de la leche materna.

Humos y Mucos con Potencial Reproductivo

Anticoncepción

Los estudios epidemiológicos han sugerido que los niños expuestos al valproato en el útero tienen puntajes de coeficiente intelectual similares a los observados en humanos y defectos neuroconductuales en la descendencia en dosis clínicamente relevantes.

Existe evidencia epidemiológica que sugiere que la exposición a Prodoxal de valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de trastornos del espectro autista.

Exposición

Ha habido informes de infertilidad masculina coincidentes con la terapia con valproato.

Existe evidencia epidemiológica que sugiere que la exposición a Prodoxal de valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de trastornos del espectro autista.

Exposición

La experiencia ha indicado que los pacientes pediátricos menores de diez años tienen un riesgo considerablemente mayor de desarrollar hepatotoxicidad fatal, especialmente aquellos con los siguientes factores de riesgo mencionados.

Se han informado casos de insuficiencia hepática en niños de este grupo de pacientes, se debe utilizar con extrema precaución y con agente único. Los beneficios de la terapia deben superarse antes de los riesgos. Por encima de los 2 años de edad, la experiencia en epilepsia ha indicado que la incidencia de insuficiencia hepática fatal disminuye considerablemente en grupos de pacientes progresivamente mayores.

Los niños más pequeños, especialmente aquellos que reciben medicamentos inductores de enzimas, requieren dosis de mantenimiento más altas para alcanzar las concentraciones de valproato tal vez objetivo. Los pacientes pediátricos (señalados, desde 3 meses y 10 años) deben recibir dosis de mantenimiento más altas que los niños más altos que los adultos. A partir de los 10 años, los niños tienen parámetros farmacocinéticos que se aproximan a los de los adultos.

La experiencia con la fracción libre limita la utilidad clínica de monitorear las concentraciones séricas totales de ácido valproico. La interpretación de las concentraciones de ácido valproico en niños debe incluir la consideración de factores tales como el metabolismo hepático y la unión a proteínas.

Resumen de datos de estudio en siete ensayos clínicos pediátricos

De los estudios pediátricos fueron ensayos doble ciego controlados con placebo para evaluar la eficacia de valproato de sodo ER para las indicaciones de matema (150 pacientes) en el día 3 a 17 años, 70 de los cuales estaban en valproato de sodo ER y migraña (304 pacientes) en el día 17 años, 201 de los cuales estaban en valproato de sodo ER. No se estableció la eficacia ni el uso de valproato de sodo ER para el tratamiento de la matema. Las reacciones adversas relacionadas con el fármaco más comunes (Frecuencia >5% y el doble de la tasa de placebo) notificadas en el estudio controlado de matema fueron náuseas, dolor abdominal superior, somnolencia, aumento de enzimas, pérdida y erupción cutánea.

Los cinco ensayos fueron estudios de seguridad a largo plazo. Se realizaron dos estudios pediátricos de seis meses para evaluar la seguridad a largo plazo de valproato de sodo ER para la indicación de matema (350 pacientes) en los 10 a 17 años. Se realizaron dos estudios pediátricos de doce meses para evaluar la seguridad a largo plazo de valproato de sodo ER para la indicación de migraña (333 pacientes) en los 12 a 17 años. Se realizó un estudio de doce meses para evaluar la seguridad de valproato de sodo Sprinkle Capsules en la indicación de migraña en pacientes menores (150 pacientes) en los 6 a 10 años.

En estos siete ensayos clínicos, la seguridad y la tolerabilidad de valproato de sodo en pacientes pediátricos demostraron ser comparables a los de los adultos.

Toxicología humana (pre) clínica
En estudios de valproato en animales inmaduros, los efectos tóxicos no observados en animales adultos incluyen deficiencia respiratoria en ratas lactantes durante el período neonatal (desde el día 4 postnatal) y neurotoxicidad en ratas lactantes durante el período neonatal y juvenil (desde el día 14 postnatal).

La dosis única para estos hallazgos fue menor que la dosis humana máxima recomendada en mg/kg.

Uso geriátrico

Ningun paciente mayor de 65 años se incluyó en ensayos clínicos prospectivos debido a la asociación con la enfermedad bipolar. En un estudio de revisión de casos de 380 pacientes, 72 pacientes (19%) tenían más de 65 años de edad. Un mayor porcentaje de pacientes mayores de 65 años reportaron niveles accidentales, infección, dolor, somnolencia y tinnitus. La interrupción del valproato se asoció ocasionalmente con los últimos eventos. No se informó si estos eventos incluyeron la exposición a un agente adicional o si son el resultado de una enfermedad médica preexistente y/o uso concomitante de medicamentos entre estos pacientes.

Los efectos de pacientes ancianos con demencia reversible relacionada con la hipoglucemia y/o disfunción por somnolencia. La dosis inicial debe reducirse y la monitorización de la respuesta y la tolerancia de la dosis de la exposición a pacientes con somnolencia excesiva. No hay suficiente información disponible para determinar la seguridad y la eficacia del valproato para la profilaxis de las migrañas en pacientes con epilepsia.

Sobredosis

La sobredosis de valproato puede provocar somnolencia, bloqueo cardíaco, coma profundo e hipernatremia. Se han reportado muertes; sin embargo, los pacientes se han recuperado de niveles de valproato de hasta 10 mg/L. La hemólisis y la hematuria en la hematuria en la hematuria pueden provocar una anemia significativa del fármaco. El beneficio de lavado gástrico o emesis varía con el tiempo transcurrido desde la ingestión. Deben aplicarse medidas generales de apoyo con especial énfasis al mantenimiento de la vía aérea adecuada. Se ha informado que la náusea intermite los efectos desfavorables del 20% de la sobredosis de valproato. Debido a que, en teoría, la náusea también podría revertir los efectos antiepilépticos del valproato, debe usarse con precaución en pacientes con epilepsia.

Ante la eventualidad de una sobredosis, consulte al hospital más cercano o comuníquese con el centro de toxicología (CAAT), Tel. 70 222.

PRESENTACIÓN

VALPROXER se presenta en envases contenidos 20, 30 y 50 comprimidos gastroresistentes.

CONSERVACIÓN

Conservar el envase original a temperatura desde 15° Celsius (30° F). Proteger de la luz.

Referencia utilizada en los estudios de equivalencia biofarmacéutica: VALCOTE® comprimidos recubiertos, Abbott Laboratorios Argentina S.A.

NO DEJE MEDICAMENTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por Gador S.A. Bs. As., Argentina - Acondicionado por Laboratorio Gador S.A. N° 259 - La Paz 2257 -

Montevideo - Tel. 2401 64 44 - Email: uy-info@gador.com

D.T. Quím. Farm. Christian Diaz - Reg. M.S.P. N° 45235 y 45236 - Ley 15443

Al cuidado de la vida